

혈청 종양 마커 중, 혈청 전립선 특이 항원(PSA)은 17.33 ng/mL(정상 < 4 ng/mL)이었지만, 겨드랑이와 주변 연부 조직에서 채취한 시료의 특수 염색은 모두 PSA 양성으로 나타나지 않았다. 기타 종양 마커, 특히 코리오프린 항원 19-1도 모두 정상 범위 내에 있었다.

환자는 전립선 생검 및 추가 검사를 거부했으며, 통증 외의 치료를 받지 않으려 했다. 가슴 벽의 종양은 점차 커졌고, 통증은 다중 부위로 확산되었다. 환자의 상태는 악화되었고, 진단 후 2개월 만에 다발성 장기부전으로 사망했다.

토론

염증성 피부 변화가 악성 종양과 관련이 있을 때, 이러한 상태는 악성 종양에 따라 명명되며, 예를 들어 염증성 암, 염증성 카피노마, 염증성 전이 등이 있다. 우리의 환자에서, 가슴 앞쪽의 연부 조직 부종과 통증, 그리고 발적 피부와 국소 열감은 겨드랑이 전이로 인해 발생한 것으로 보였다. 또한, 연부 조직 부종과 기포 형성은 겨드랑이 근육을 통해 퍼져 있었다. 우리는 이 상태를 겨드랑이의 염증성 전이성 카피노마로 가정했다. Bachmeyer 등(1)은 두 명의 폐 아데노카피노마로 인한 겨드랑이 전이 환자에 대한 보고서에서 이 상태를 '염증성 겨드랑이 전이'라고 명명했다. 이 환자들은 38°C 이상의 발열과 높은 ESR 및 CRP 수치를 보였으며, 우리의 경우와 유사했다. Thongram 등(2)은 편평상피 세포암으로 인한 염증성 겨드랑이 전이의 또 다른 사례를 보고했다. 그들은 44세 여성을 보고했는데, 이 환자는 상부 겨드랑이와 흉골연골 결합부 통증으로 병원을 찾았다. 처음에는 Tietze 증후군으로 진단되었고, 비스테로이드 항염증제로 치료를 받았다. 이후, 가슴 앞쪽의 만져보는 통증과 약간의 부종이 나타나자, 세침흡입 검사를 시행했다. 병리학적 검사 결과는 원인 불명의 편평상피 세포암으로 나타났다. 이전의 세 가지 사례(1, 2)와 우리의 경우의 차이점은 겨드랑이 근육을 통해 퍼진 공기의 CT 소견이었다. 우리는 처음에 이 증상을 겨드랑이와 흉골연골 결합부의 골염과 골수염과 관련된 기혈종으로 가정했다. 그러나 추적 CT에서 근육 내 기가 흡수되었음에도 불구하고 연부 조직의 증강이 회복되지 않음에 따라 악성 종양의 가능성이 제기되었다.

현재 사례의 흥미로운 점은 자연발생 기혈종이 겨드랑이 전이와 관련이 있다는 점이며, 이는 우리가 아는 바에 따르면 처음으로 보고된 경우이다. 일반적으로 기혈종은 클로스트리듐 종류(예: 클로스트리듐 페르FRING엔스) 또는 다중 미생물 감염에 의해 발생하며, 오염된 관통성 근육 손상과 관련이 있다. 우리의 경우, 문화 검사에서 미생물이 검출되지 않았으며, 입구 경로를 암시하는 명확한 상처도 없었다. 또한, 기혈종은 모든 근육, 피하 조직 및 피부 층에 영향을 미치는 급격히 진행되고 치명적인 상태로, 긴급한 수술적 드레인을 필요로 한다(3, 4). 그러나 우리의 환자는 기혈종의 일반적인 악화되는 임상 경과를 보이지 않았다.

우리는 원발 악성 종양을 찾아보려 했다. 겨드랑이는 원발 또는 전이성 종양에 관계없이 종양의 흔한 위치는 아니다. 겨드랑이의 흔한 악성 종양은 유방, 갑상선, 신장, 소화기, 간, 폐, 그리고 드물게 전립선에서 온 전이성 아데노카피노마이다(2, 5, 6). 우리의 환자에서, 골 전이는 PET-CT 검사에서 이미 너무 광범위하게 진행된 상태였다. 조직학적 검사에서 편평상피 세포암의 증거는 없었으며,